2040年問題を先取る小樽で顕在化する

生活破綻型救急と「生活を守る医療」の重要性

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
済生会小樽病院　内科部長　諸原 基貴

COI：なし

救急車有料化に賛成

有料化は

『救急医療の継続性』

の議論

該当する条件

・自ら判断できる
・自ら移動手段を準備できる
・日中に病院に受診できる

それでも救急車を利用する

真に救急医療を必要とする患者の医療資源を守る

小樽での問題は何か

人口
約10万人

高齢化率
42%超

2040年の課題が
すでに顕在化している

・高齢者の増加
・生産年齢人口の減少
・医療・介護需要の増加　など

救急搬送／軽症搬送は増加

➡ **生活破綻型救急が顕在化**

生活破綻とは

生活破綻：生活機能の低下により、現在の生活が成り立たなくなる状態

身体	精神	社会
Multimorbidity Frailty	Agency（主体性）の枯渇 MCI・認知症	支援不足
身体機能の低下	**意思決定能力の低下**	**社会とのつながりの低下**

三つの生活機能低下が相互に影響し、生活破綻に至る

生活破綻の症例

症例1：自宅生活の限界

Multimorbidity

複数診療科で標準治療

生活機能維持困難

症例2：施設生活の限界

2か月前から嚥下機能低下

栄養剤も摂取不能

経口摂取困難は施設で見れない

生活を見てくれる
かかりつけ医の不在

ACP未実施
限界の共有なし

生活破綻型救急の本質

共通点 1　生活を続けられなくなった

共通点 2　限界を予測できた

病気ではなく　機能障害の進行が

予測可能な限界に到達　障害の進行

予測可能なのに、対応ができない社会

これまで見えていなかった
社会的な準備不足・支援体制の不足が顕在化

ACP

本人・家族の備え

守るべき生活

病診連携

施設限界の共有

医介連携

救急医療が担わされている社会的課題

救急医療の役割

急性疾患の対応 ✚

生活の再設計
生活の継続性の検討
終末期IC
ACP構築
家族との意思決定支援

救急医療が、生活破綻の最終責任を引き受けるの？

目的のズレ

医療の目的

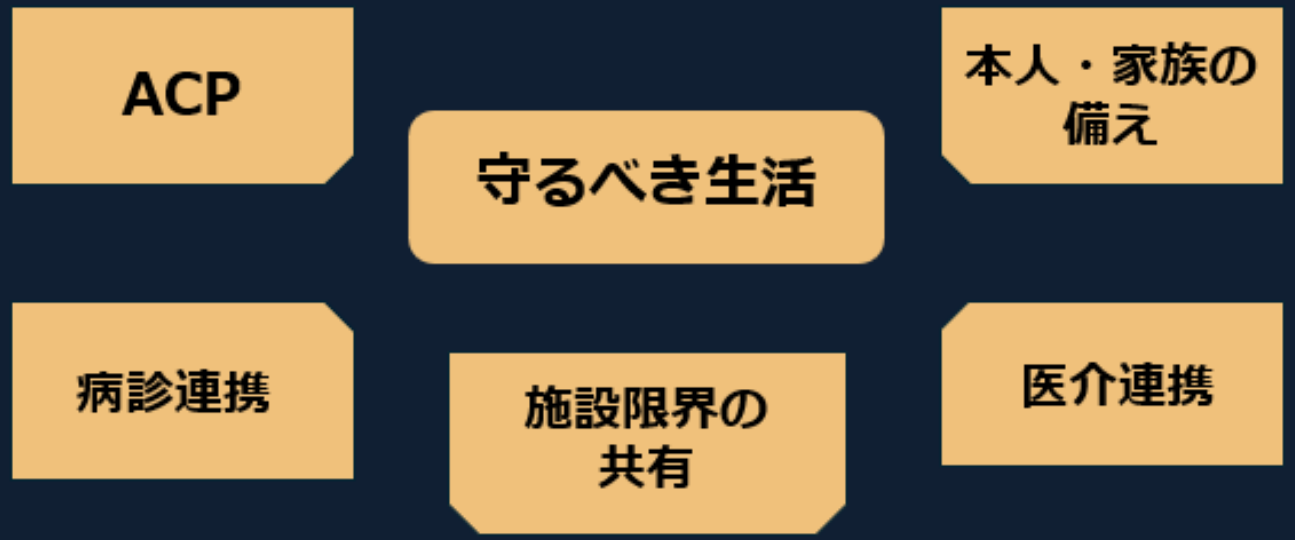
疾患・臓器の治療
数値改善
ガイドライン達成

患者の目的

今の生活を続ける
自宅・施設で暮らす
自分らしく生きる

目的を共有しなければ、予測可能な限界も共有できない

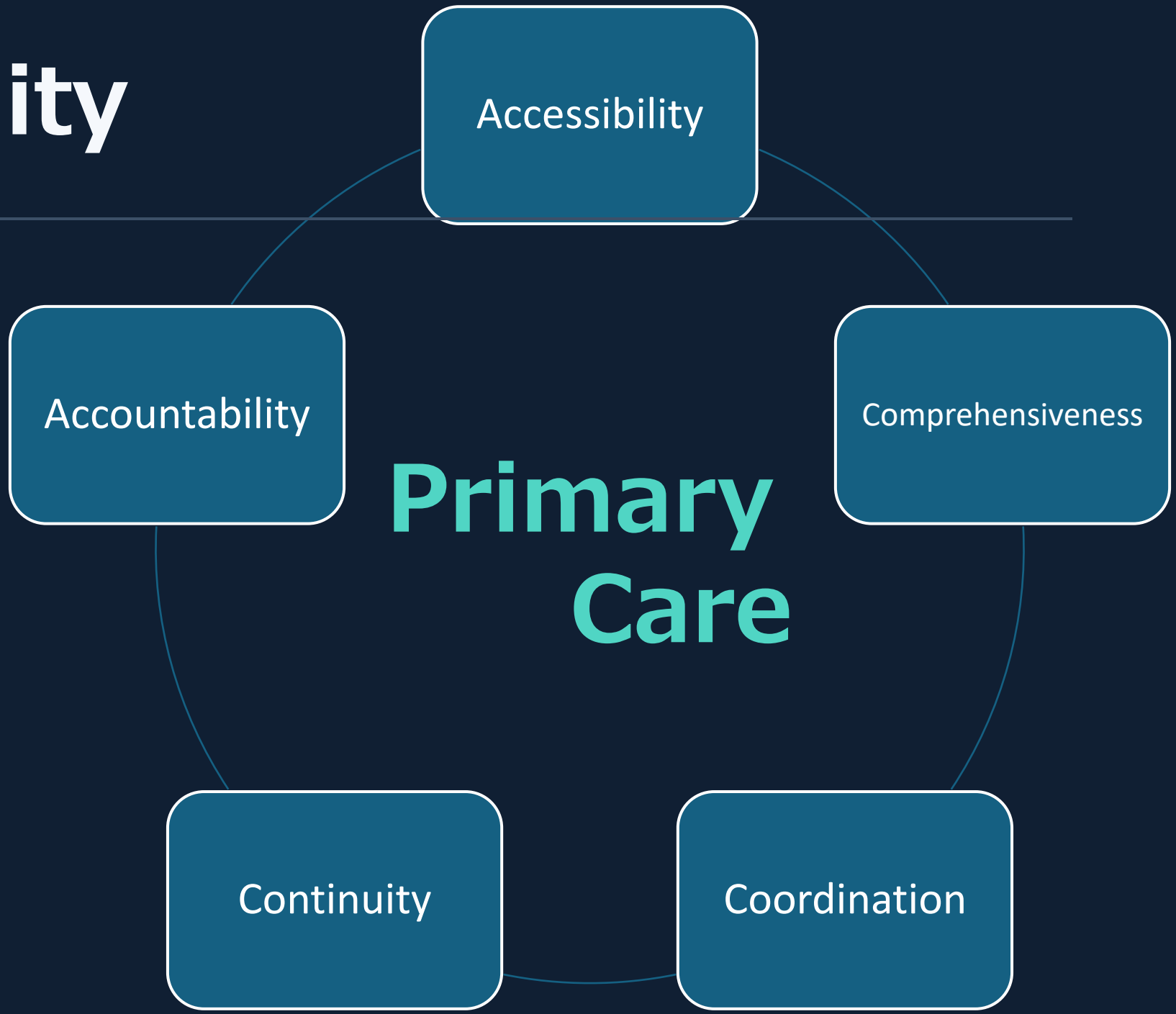
生活を守るという視点



予測可能な限界を共有し、 Accountability

適切なタイミングで適切に対応する責任

Accountability



生活を守るという視点

結語

医療と患者の目的

不一致

生活破綻

一致

生活を守る

救急医療の継続性

小樽フレイルケアプロジェクト
https://frailcareteam.github.io/FrailCareProject/